

CRISE DE ASMA + BÔNUS: DPOC EXACERBADO



ROTINA CLÍNICA

Modelos de prescrição

CRISE DE ASMA

- **Oxigênio:**

Meta de **saturação > 92%** (em crianças e gestantes > 95%).

Em geral, cateter nasal de oxigênio, 1 a 3 litros por minuto (usar o menor fluxo possível adequado para o paciente).

- **β 2 Agonistas de curta ação:**

Devem ser administrados imediatamente após a apresentação clínica!

Como prescrever? **4 a 10 puffs de salbutamol (100 mcg/dose), repetir a cada 20 minutos na primeira hora (3 ciclos) e depois a cada 1 a 4 horas.**



CRISE DE ASMA

- **Nebulização:**

A maioria das diretrizes recomenda seu uso em pacientes com exacerbações graves (apesar de ter eficácia similar aos dispositivos inalatórios do tipo “bombinha”).

Como prescrever?

Sulfato de Salbutamol gotas 5 mg/ml

Diluir 10 gotas (2,5 mg) em 3 a 5 ml de soro fisiológico 0,9%. → **Nebulizar de 20 em 20 minutos na 1ª hora.** Pode-se associar 40 gotas de Brometo de Ipratrópio em cada nebulização.

Ou

Fenoterol solução gotas 5 mg/ml

Diluir 10 gotas (2,5 mg) em 3 a 5 ml de soro fisiológico 0,9% → **Nebulizar uma vez.**

Pode-se associar 40 gotas de Brometo de Ipratrópio.



ROTINA CLÍNICA

CRISE DE ASMA

- **B2-Agonistas parenterais:**

Não apresentam benefícios adicionais e são associados a complicações.

Salbutamol injetável (500 mcg/mL):

A dose via SC ou IM é de 250 a 500 mcg até de 4 em 4 horas. Dose EV não é padronizada, mas sugere-se 250 mcg em infusão lenta.



ROTINA CLÍNICA

CRISE DE ASMA

- **Anticolinérgicos:**

Meta-análise evidenciou **redução significativa na taxa de admissão hospitalar com a adição de ipratrópio.**

Como prescrever?

Brometo de Ipratrópio (alta disponibilidade e baixo custo), dose de 40 gotas (500 mcg), repetida em inalações com o β_2 agonista.

Em aerossol, a dose usual é de 2 a 3 puffs (400 a 600 mcg), com intervalo de 6 a 8 horas.



ROTINA CLÍNICA

CRISE DE ASMA

- **Corticosteroides sistêmicos:**

Seu uso deve iniciar ainda no serviço de emergência, podendo ser administrado via oral (devido à absorção rápida e segura) ou endovenosa (se houver diarreia, vômitos ou exacerbação muito grave).

Oral: Prednisona 40 mg, VO.

Parenteral: Hidrocortisona 250 mg EV diluídos em 100 ml de SF 0,9%, infundir em 30 minutos.

Na alta: corticoide via oral por 5 a 7 dias (não é necessário desmame para suspensão).



CRISE DE ASMA

- **Sulfato de Magnésio:**

Efeito benéfico apresentado em algumas revisões sistemáticas no subgrupo de asmáticos com **exacerbação grave**.

Dose: 1,2 a 2,0 gramas diluídos em 100 a 500 ml de solução fisiológica 0,9%, infundidos em 20 minutos.

Sugestão: Sulfato de Magnésio 10% (1g/ampola). Diluir o conteúdo de 2 ampolas em 250 mL de SF 0,9% e infundir em 20 minutos.



RACIONAL

- Para exacerbações leves/moderadas:

Salbutamol spray (100 mcg/dose): Inalar 4 a 10 puffs e repetir a cada 20 minutos na primeira hora (realizar 3 ciclos) → reavaliar paciente após 01 hora.

OU

Sulfato de Salbutamol gotas 5 mg/ml

Diluir 10 gotas (2,5 mg) em 3 a 5 ml de soro fisiológico 0,9%. → Nebulizar de 20 em 20 minutos na 1ª hora (e reavaliar após 1 hora). Associar 40 gotas de **Brometo de Ipratrópio** em cada nebulização.

Além disso, prescrever **corticoide** oral ou parenteral conforme descrito na página 6.



ROTINA CLÍNICA

RACIONAL

Após as medidas iniciais da 1ª hora:

- Considerar alta ou otimização de medidas para broncoespasmo ou proceder com internação hospitalar.

****** Caso não haja melhora clínica → **otimizar medidas** e reavaliar em 1 hora.

****** Caso não haja melhora após a otimização terapêutica → proceder com **internação**.



CRISE DE ASMA

- Após a abordagem inicial, teremos 2 cenários possíveis:

1) Paciente com exacerbação leve a moderada, estável hemodinamicamente e com boa resposta às medidas para broncoespasmo instituídas (reavaliar em 1 e 3 horas após as medidas): **considerar alta e seguimento ambulatorial.**

2) Paciente com exacerbação grave ou eminência de PCR, instável hemodinamicamente, com resposta ruim ou incompleta às medidas: **otimizar medidas ou avaliar internação hospitalar.**



CRISE DE ASMA

- **Corticoide inalatório:**

Seu uso é importante para **prevenir novas crises** de asma após a descontinuação dos glicocorticoides orais e para **evitar a potencial diminuição da função pulmonar** associada com futuras exacerbações graves.

De modo geral, TODO paciente com exacerbação grave o suficiente para necessitar de atendimento urgente deve receber um glicocorticoide inalatório como parte do plano terapêutico para a alta, além de iniciar/continuar o acompanhamento ambulatorial. É razoável iniciar a terapia de **etapa 4 (do GINA)** ou **aumentar a terapia atual do paciente em uma etapa (o que for maior)**.



CRISE DE ASMA

- **Corticoide inalatório:**

Formoterol+Budesonida 6/200 mcg ---- 1 Frasco

Realizar 2 inalações de 12/12h. Lavar a boca após o uso da medicação.

(Pode-se utilizar tal medicação como SOS, administrando uma dose adicional caso haja crise - máximo de 8 jatos por dia).

Alternativa SUS:

Dipropionato de Beclometasona 50 mcg/dose ---- 1 Frasco

Inalar 04 jatos de 12/12h. Lavar a boca após o uso.



ROTINA CLÍNICA

PARA CASA

- **Uso Oral:**

Prednisona 20 mg ----- 10 comprimidos

Tomar 2 comprimidos pela manhã por 5 dias.

- **Uso Inalatório:**

Formoterol+Budesonida 6/200 mcg ---- 1 Frasco

Realizar 2 inalações de 12/12h. Lavar a boca após o uso da medicação.

Salbutamol spray 100 mcg/dose ---- 1 Frasco

Inalar 2 a 4 jatos de 4/4h em caso de dispneia (falta de ar) ou sibilância (chiados).

Dipropionato de Beclometasona 50 mcg/dose ---- 1 Frasco

Inalar 4 jatos de 12/12h. Lavar a boca após o uso.



PARA CASA

- **Orientações:**

Manter acompanhamento ambulatorial.

Em caso de sinais de alarme (incluindo: dispneia e recorrência dos sintomas de broncoespasmo), procurar atendimento médico.

Evitar exposição aos alérgenos/substâncias que provocam piora dos sintomas respiratórios.



BÔNUS: DPOC EXACERBADO

Definição:

É caracterizada por **piora aguda** dos sintomas respiratórios em relação ao habitual do paciente com DPOC.

Via de regra, é desencadeada por infecções (**virais** - a maioria e também bacterianas) ou por exposição a fatores ambientais desencadeantes.

Diagnóstico:

O diagnóstico é **clínico** e envolve a presença de **um ou mais** das seguintes manifestações:

- 1) Piora da dispneia;
- 2) Piora do aspecto da expectoração (purulento);
- 3) Aumento da quantidade de expectoração.



BÔNUS: DPOC EXACERBADO

Tratamento (ABCD):

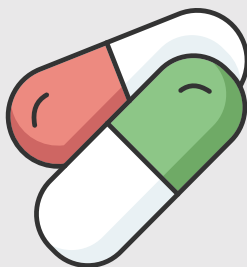
A) Antibiótico:

Indicado nas seguintes situações:

- 1) Presença dos 3 sintomas cardinais;
- 2) Presença de 2 sintomas cardinais, sendo 1 deles escarro purulento;
- 3) Necessidade de ventilação mecânica (VM).

Sugestões (duração de 5 a 7 dias):

- Amoxi.+Clavulanato 875/125 mg, 12/12h;
- Ceftriaxona 2g/dia EV + Azitromicina 500 mg/dia;
- Levofloxacino 500-750 mg 1x/dia.



BÔNUS: DPOC EXACERBADO

Tratamento (ABCD):

B) Broncodilatador:

**B2 adrenérgico de curta ação +
anticolinérgico**

Salbutamol 5mg/mL 10 gotas (2,5 mg) +
Ipratrópio 40 gotas (0,5 mg) em 3mL de SF
0,9%.

Sugestão:

Iniciar com 1 inalação a cada 20 minutos, por
3 vezes (03 ciclos).

Intervalo usual para repetir nebulização:

Casos leves: 6/6 horas;

Casos graves: 3/3 horas ou até de 1/1 hora.



ROTINA CLÍNICA

BÔNUS: DPOC EXACERBADO

Tratamento (ABCD):

C) Corticoide:

VO: Prednisona 40 mg por 5 a 7 dias.

OU

EV: Hidrocortisona 250 mg.

Indicado nos **casos graves** ou **sem disponibilidade de realizar por via oral**.

Observação: **Não há** diferença estatística significativa entre a via oral e parenteral quanto à falha do tratamento, recidiva ou mortalidade.



ROTINA CLÍNICA

BÔNUS: **DPOC EXACERBADO**

Tratamento (ABCD):

D) "Dar" Oxigênio:

Ofertar o **menor fluxo** necessário para alvo de saturação entre **88-92%**.

Sugestão:

Iniciar com cateter nasal de O₂ e observar.

Detalhe: Evitar máscaras reinalantes.

Indicações de VNI:

Acidose respiratória ($\text{pH} \leq 7,30$ e $\text{pCO}_2 > 60\text{mmHg}$);

Dispneia moderada a grave com sinais de fadiga muscular e/ou uso de musculatura acessória;

Hipoxemia refratária ao uso de oxigênio.

